Клинические рекомендации

Грибковый отит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B37.8** — Кандидоз других локализаций **B44.8** — Другие виды аспергиллеза **B49** — Микоз неуточненный **H60.8** — Другие наружные отиты **H62.2** — Наружный отит при микозах **H66.3** — Другие хронические гнойные средние отиты
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/304_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение и формы 3

2.2 Возбудители и предрасполагающие факторы 3

2.3 Жалобы и анамнез 4

2.4 Картина по возбудителю 4

3. Диагностика 5

3.1 Отомикроскопия 5

3.2 Микологическое исследование отделяемого из уха 6

3.3 Анализы крови 6

4. Лечение 7

4.1 Наружный грибковый отит 7

4.2 Грибковый средний отит и микоз послеоперационной полости 7

4.3 Туалет уха 8

4.4 Хирургическое лечение 8

4.5 Немедикаментозное лечение 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9

5.1 Показания к госпитализации 9

5.2 Диспансерное наблюдение и профилактика 9

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Отомикоз: грибковое поражение кожи ушной раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки, барабанной полости или послеоперационной полости среднего уха. Основными возбудителями являются плесневые грибы Aspergillus и дрожжеподобные грибы Candida. Течение хроническое, рецидивирующее.
- Диагноз устанавливается только после выявления возбудителя: микроскопия и посев отделяемого из уха на грибы. Однократный отрицательный результат микоз не исключает.
- Лечение: тщательный туалет уха врачом и местные противогрибковые аппликации, при среднем отите и микозе послеоперационной полости — также противогрибковые препараты внутрь. Критерий излечения: клиническое выздоровление в течение месяца и отрицательное микологическое исследование.
- Госпитализация:
  1. осложнённый грибковый средний отит;
  2. лабиринтит;
  3. невозможность ежедневного туалета уха;
  4. нет эффекта амбулаторного лечения наружного грибкового отита **за 5–7 дней**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение и формы

1. грибковый наружный отит: плесневые или дрожжеподобные грибы на коже ушной раковины, стенках наружного слухового прохода, барабанной перепонке;
2. грибковый мирингит: плесневые грибы на барабанной перепонке;
3. грибковый средний отит: плесневые и дрожжеподобные грибы в барабанной полости;
4. микоз послеоперационной полости среднего уха.

Синоним: отомикоз (ОМ).

Классификация

1. по локализации: наружный грибковый отит, грибковый мирингит, грибковый средний отит, грибковый средний послеоперационный отит;
2. по возбудителю: плесневой, дрожжеподобный, смешанный;
3. по течению: хронический.

2.2 Возбудители и предрасполагающие факторы

Основными возбудителями являются плесневые грибы рода Aspergillus и дрожжеподобные грибы рода Candida. Все возбудители условно-патогенные: заболевание развивается при наличии предрасполагающих факторов.

Частота возбудителей

1. аспергиллёз: 65% случаев;
2. кандидоз: 30%;
3. Penicillium, Mucor, Alternaria, Geotrichum, Cladosporium и другие грибы: до 5%;
4. сочетанное поражение Aspergillus и Candida: 15% случаев.

Виды: Aspergillus niger, fumigatus, oryzae, flavus и другие; Candida albicans, tropicalis, krusei, glabrata, parapsilosis и другие; Penicillium notatum и другие.

Предрасполагающие факторы

1. травма кожи при чрезмерной гигиене слухового прохода с удалением защитной серы;
2. сахарный диабет: глюкоза в ушной сере повышается уже на ранних стадиях;
3. соматические заболевания, нарушение обмена веществ, гиповитаминоз;
4. длительная системная и местная антибиотикотерапия, кортикостероиды;
5. иммунодепрессанты, лучевая терапия.

Микоз послеоперационной полости

1. длительное воспаление в полости с повреждением эпителия;
2. травма уха, в том числе операционная;
3. попадание нестерильной воды;
4. влажность, запылённость, производственный контакт с антибиотиками.

Для грибкового отита характерно рецидивирующее течение.

2.3 Жалобы и анамнез

Наружный грибковый отит

1. жидкие выделения (кандидоз);
2. корочки и пробки в слуховом проходе (аспергиллёз);
3. зуд, боль, заложенность уха;
4. в острой стадии иногда головная боль, лихорадка, болезненность раковины, заушной области и слухового прохода.

Слух не снижен или снижен незначительно по кондуктивному типу.

Грибковый средний отит

1. снижение слуха;
2. выделения из уха;
3. периодический зуд;
4. возможны головокружения.

Течение длительное; обострения — выраженная боль, зуд, заложенность, выделения, головная боль, головокружение.

В анамнезе уточняют

1. начало и течение болезни, частоту и характер обострений;
2. прежние отиты и микозы другой локализации;
3. прежнее лечение и его эффект;
4. лечение антибиотиками, кортикостероидами, иммунодепрессантами: длительность и интенсивность;
5. производственные и бытовые условия, аллергологический анамнез.

Для отомикоза характерны учащение обострений и слабый эффект стандартного лечения.

2.4 Картина по возбудителю

Возбудитель	Картина
Дрожжеподобные (Candida)	1. в процесс может вовлекаться кожа раковины и околоушной области; 2. гиперемия, инфильтрация и мацерация кожи слухового прохода, гиперемия барабанной перепонки; 3. при среднем отите утолщение слизистой, густое мутное отделяемое; нарушение эпителизации послеоперационной полости; 4. беловатое, менее густое отделяемое; на раковине эрозии, легко снимающиеся беловатые налёты; возможен хондроперихондрит.

Возбудитель	Картина
Aspergillus	1. казеозно-некротические массы; 2. инфильтрация сильнее в костном отделе, возможен мирингит; 3. беловато-серые наложения с чёрными вкраплениями: «молотый перец», «промокшая газета»; 4. Aspergillus glaucus: зеленоватое отделяемое.
Penicillium	1. желтоватое отделяемое, иногда как сера, по всему слуховому проходу; 2. инфильтрация кожи, сухие корочки и плёнки.
Geotrichum capitatum	1. выраженная инфильтрация кожи, мирингит; 2. плотные «замазкообразные» серовато-жёлтые массы по всему слуховому проходу.

3. Диагностика

Диагноз основан на комплексе: жалобы, анамнез, физикальное, лабораторное и инструментальное обследование.

3.1 Отомикроскопия

Показания

1. все пациенты: осмотр наружного слухового прохода, барабанной перепонки, барабанной полости и послеоперационной полости под микроскопом, отоскопом или торцевым эндоскопом.

Общий признак всех форм

1. окрашенное отделяемое в слуховом проходе и (или) среднем ухе.

Диагноз «отомикоз» устанавливается только после выявления возбудителя.

Осмотр с увеличивающей оптикой: отоскоп, микроскоп, торцевой эндоскоп.

Форма	Отоскопические признаки
Кандидоз наружного слухового прохода	1. умеренное сужение просвета, сильнее в хрящевом отделе; 2. барабанная перепонка гиперемирована; 3. отделяемое жидкое, беловатое, творожистое; 4. процесс часто переходит на кожу раковины.
Аспергиллёз	1. сужение за счёт инфильтрации, сильнее в костном отделе; 2. барабанная перепонка почти всегда инфильтрирована, утолщена, без опознавательных контуров; иногда грануляции; 3. обильное отделяемое разных оттенков серого, иногда с чёрными точками, холестеатомо- или сероподобное, как промокшая газета.
Пенициллиоз	1. процесс в хрящевом отделе, умеренная инфильтрация без полного закрытия прохода; 2. барабанная перепонка гиперемирована, иногда эрозирована или выпячена — ложное впечатление перфорации; 3. отделяемое оттенков жёлтого, как сера, по всему проходу, с сухими корочками и плёнками.

Форма	Отоскопические признаки
Грибковый средний отит	1. специфическое отделяемое, цвет и консистенция по виду гриба; 2. часто сопутствует наружный отит; 3. барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, перфорации разного размера; 4. слизистая барабанной полости гиперемирована, инфильтрирована, иногда грануляции.
Микоз послеоперационной полости	1. эпителизации нет или она резко замедлена; 2. стенки прохода гиперемированы, неравномерно инфильтрированы; 3. неотимпанальная полость заполнена отделяемым, как при отомикозе другой локализации; 4. мелкие кровоточащие грануляции.

3.2 Микологическое исследование отделяемого из уха

Показания

1. все пациенты: микроскопия отделяемого на дрожжевые и мицелиальные грибы, посев на дрожжевые и на мицелиальные грибы.

При хроническом отите обязательно, если

1. частые обострения (**1 раз в 2 месяца**);
2. противовоспалительная антибактериальная терапия неэффективна;
3. характерная отоскопическая картина микоза.

После лечения — контрольные исследования.

Забор и исследование материала

1. материал берут аттиковым зондом или ложкой Фолькмана из глубоких отделов слухового прохода под контролем микроскопа, отоскопа или эндоскопа;
2. помещают между двумя обезжиренными стерильными стёклами, микроскопия при увеличении ×100, ×200, ×400;
3. микроскопия является наиболее информативным методом и надёжно определяет возбудителя;
4. критерий микоза при посеве: титр грибов **не менее 10^4 КОЕ/мл**.

Повторное исследование: однократный отрицательный результат не исключает грибковое заболевание, а единичный рост грибов в посеве не всегда означает микоз. Решающее значение имеют микологические методы, а не отоскопия.

3.3 Анализы крови

Показания

1. затяжное и рецидивирующее течение: поиск сопутствующих и фоновых заболеваний.

Исследования

1. общий (клинический) анализ крови;
2. биохимия: глюкоза, общий белок, АСТ, АЛТ, креатинин;
3. антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2;
4. антитела к бледной трепонеме;
5. HBsAg (гепатит B), антиген вируса гепатита C.

При поражении уха на фоне системных, в том числе инфекционных, заболеваний показаны консультация соответствующего специалиста и дообследование.

4. Лечение

Всем пациентам лечение начинают с элиминации возбудителя: противогрибковая терапия и тщательный туалет слухового прохода, барабанной или послеоперационной полости. Учитывают прежние эпизоды микоза и местные противогрибковые препараты.

Местную терапию начинают, не дожидаясь результатов посева.

Схема лечения отомикоза

Локализация	Дрожжеподобные грибы	Плесневые грибы
Наружное ухо, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Среднее ухо, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Среднее ухо, внутрь	#флуконазол, капсулы	#итраконазол, капсулы
Послеоперационная полость, местно	нафтифин 1% раствор + клотримазол 1% раствор	нафтифин 1% раствор + хлорнитрофенол 1% раствор
Послеоперационная полость, внутрь	флуконазол, капсулы	итраконазол, капсулы, или #тербинафин, таблетки (с 3 лет)

4.1 Наружный грибковый отит

Кандидозный отит: аппликации 1% раствора #клотримазола и 1% раствора #нафтифина.

1. по 5–10 минут 2 раза в сутки, **14 дней**;
2. затем ещё **14 дней** после стихания клинических признаков и (или) до 3-кратного отрицательного анализа.

Возможны также миконазол, натамицин, #эконазол.

Плесневые грибы: аппликации #хлорнитрофенола и 1% раствора #нафтифина на кожу слухового прохода.

1. по 5–10 минут 2 раза в день, **10–14 дней**;
2. затем ещё **14 дней** после стихания клинических признаков и (или) до 3-кратного отрицательного анализа.

Грибково-бактериальная ассоциация: применяют комбинированные ушные капли #хлорамфеникол + беклометазон + клотримазол + лидокаин.

1. по 4–5 капель 3–4 раза в день, **10 дней**; детям **с 6 лет**.

4.2 Грибковый средний отит и микоз послеоперационной полости

Candida: помимо местного лечения назначают противогрибковый препарат внутрь — #флуконазол в возрастной дозе.

Плесневые грибы: назначают итраконазол или тербинафин внутрь; местная терапия — как при наружном грибковом отите.

Дозы противогрибковых препаратов системного действия

1. #флуконазол: внутрь 50–100 мг 1 раз в сутки, **14 дней**;
2. #итраконазол: внутрь 200 мг 1 раз в сутки, **10–14 дней**;
3. #тербинафин: внутрь 250 мг в сутки, **16 дней**.

Возрастная группа в таблице 2 КР не указана. Детям #флуконазол назначается в возрастной дозировке, конкретная доза в КР не приведена; #тербинафин — **с 3 лет** (таблица 1 КР).

Критерий эффективности: полное клиническое излечение **в течение месяца**, подтверждённое клинической картиной и отрицательным микологическим исследованием.

Общая длительность противогрибковой терапии местного и (или) системного действия, по критериям качества КР, — **28 дней и более**.

Свойства препаратов для местного лечения

1. нафтифин: фунгистатичен к Candida, фунгициден к плесневым грибам, есть противовоспалительный эффект, долго держит концентрацию в коже;
2. хлорнитрофенол: противогрибковое и антибактериальное действие, в высоких концентрациях активен и против Proteus и синегнойной палочки;
3. клотримазол: высокоспецифичен к Candida, преимущественно фунгистатичен.

4.3 Туалет уха

Показания

1. все пациенты: тщательная очистка уха от отделяемого перед местной терапией.

Туалет уха выполняет только врач: аттиковым зондом и (или) ушным зондом с ватой, смоченной противогрибковым препаратом, или вакуум-экстрактором. Даже небольшое количество грибковых масс заметно удлиняет лечение.

Особенности

1. наружный отит: особенно передненижний отдел слухового прохода;
2. средний отит: полностью удалить массы из области перфораций; при больших перфорациях промывание барабанной полости 0,01% раствором бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония;
3. послеоперационный микоз: очищают всю неотимпанальную полость, особенно задний отдел за шпорой.

Препарат вводят в ухо на турунде: спиртсодержащие капли раздражают слуховой проход, а при среднем отите вызывают резкую боль, отёк слизистой, усугубление мукозита и грануляции. Турунда удлиняет действие препарата.

4.4 Хирургическое лечение

Показания

1. полипы, грануляции: до медикаментозной терапии удаление или туширование 10% раствором нитрата серебра.

После туширования обязательна обработка местным противогрибковым препаратом, например нафтифином или хлорнитрофенолом.

4.5 Немедикаментозное лечение

Физиотерапия не рекомендуется. Следует ограничить воздействие пыли, газов и повышенной влажности; решающее значение имеет предотвращение попадания воды в ухо.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. осложнённые формы грибкового среднего отита;
2. лабиринтит;
3. невозможность ежедневного адекватного туалета слухового прохода;
4. неэффективность адекватной амбулаторной терапии наружного грибкового отита **в течение 5–7 дней**.

Первичную помощь оказывают врачи общей практики и оториноларингологи первичного звена. Медицинская реабилитация не проводится.

5.2 Диспансерное наблюдение и профилактика

Частота осмотров

1. все пациенты с грибковым отитом: осмотр оториноларинголога **1 раз в 3 месяца**, при благоприятном течении **1 раз в полгода**, в течение **2 лет**.

Профилактика

1. правильный туалет слухового прохода и ушной раковины;
2. коррекция гликемии;
3. общеукрепляющая терапия.

Профилактика рецидивов

1. динамическое наблюдение в течение **6 месяцев**;
2. курс профилактического лечения;
3. смазывание кожи слухового прохода нафтифином или хлорнитрофенолом 1 раз в неделю в течение **4–6 недель**.

Повторные посевы из уха — до микробиологического подтверждения элиминации возбудителя.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Грибковый отит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	`304_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.